

HEPARINAS Y FONDAPARINUX CALCULADORAS

J.T. Camino Acha.

ARIXTRA (FONDAPARINUX)

1. Tratamiento de Trombosis venosa profunda (TVP) y el Embolismo pulmonar (EP)

Peso del Paciente	Dosis (1 vez/día)
• < 50 kg	• 5 mg
• 50 - 100 kg	• 7,5 mg
• > 100 kg	• 10 mg

Si aclaramiento de creatinina < 30 ml/min: no administrar

2. Dosis de tratamiento de la Angina inestable (AI) y el Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IMSEST)

Dosis	Presentación
• 2,5 mg 1 vez/día	Arixtra 2,5 mg

- Si aclaramiento de creatinina < 20 ml/min: no administrar
- En caso de intervención coronaria percutánea se debe administrar heparina no fraccionada complementaria durante la intervención según práctica médica estándar.

3. Tratamiento de la Trombosis venosa superficial y Profilaxis del Tromboembolismo venoso (TEV)

Aclaramiento de creatinina	Dosis 1 vez/día
• > 50 ml/min	• Arixtra 2,5 mg
• 20 - 50 ml/min	• Arixtra 1,5 mg

- Si aclaramiento de creatinina < 20 ml/min: no administrar
- TVS: tratamiento mínimo 30 días. Máximo 45 días en pacientes con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas
- La profilaxis del tromboembolismo venoso incluye:
 - Profilaxis en cirugía ortopédica mayor de miembros inferiores y en cirugía abdominal con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas y no debe administrarse antes de 6 horas tras la cirugía.
 - Profilaxis en pacientes no quirúrgicos inmovilizados por enfermedad aguda considerados de alto riesgo.

HIBOR (BEMIPARINA)

1. Tratamiento de TVP

Peso	Unidades
• <50 Kg • 50-70 Kg • 70-100 Kg • 100-120 Kg • > 120 kg.	• 5.000 UI / 24h • 7.500 UI / 24h • 10.000 UI / 24h • 12.500 UI / 24h • Administrar a 115 UI / Kg / 24h.

2. Profilaxis de TVP

- Hibor 3500UI subcutaneo cada 24h.
- Hibor 2500UI subcutaneo cada 24h si Cr< 30 ml/min.

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha técnica hibor. https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64166/FT_64166.pdf